लघवी होतेय, मग डायलिसिसची गरज का?

> हा प्रश्न पडणे अगदी स्वाभाविक आहे. लघवीचे प्रमाण आणि रक्त शुद्ध करण्याची क्षमता यातला फरक समजून घेऊया.

लघवी दिसते; सगळी स्वच्छता दिसत नाही

डायलिसिस सुरू झाल्यावरही काही जणांची लघवी चालू असते. त्यामुळे “किडनी काम करतेय, मग हे उपचार कशाला?” असे वाटू शकते. पण पाणी बाहेर जाणे आणि रक्तातला टाकाऊ पदार्थ व पोटॅशियम योग्य प्रमाणात ठेवणे ही एकच गोष्ट नाही. उरलेले किडनीचे काम किती पुरतेय, हे **फक्त लघवी पाहून ठरत नाही**.

उपचारांचे वेळापत्रक कसे ठरते?

डॉक्टर रक्ताच्या तपासण्या, सूज, श्वासाचा त्रास, वजनातील बदल, उरलेले किडनीचे कार्य आणि डायलिसिसमधून होणारी पुरेशी शुद्धी पाहतात. एकाला चालणारे वेळापत्रक दुसऱ्याला सुरक्षित असेलच असे नाही. प्रवास, खर्च किंवा कामाच्या अडचणी असतील तर त्या नक्की सांगा; त्यासाठी सत्र स्वतःहून चुकवण्याऐवजी टीमबरोबर उपाय शोधता येतील.

पाणी आणि खाणे: दुसऱ्याची यादी आपल्या ताटात नको

सर्वांसाठी एक लिटर पाणी किंवा अतिशय कमी प्रथिने असा नियम नाही. डायलिसिसचा प्रकार, लघवी, तपासण्या आणि पोषण यानुसार योजना बदलते. डायलिसिस चालू असताना प्रथिनांची गरज वेगळी असू शकते. शेजाऱ्याचे पथ्य पाळून स्वतःचे खाणे कमी केल्यास ते आपल्यासाठी योग्य असेलच असे नाही.

घरी नोंद काय ठेवायची?

पुढच्या भेटीसाठी वजन, सूज, दम लागण्याची वेळ, भूक, लघवीत जाणवलेला बदल आणि घेत असलेली औषधे लिहून ठेवा. पाण्याची मर्यादा सांगितली असेल तर चहा, दूध, सूप यांची त्यात मोजणी कशी करायची हेही विचारा. आपला ठरलेला कार्यक्रम पाळा; बदल हवा असेल तर आधी उपचार करणाऱ्या टीमशी बोला.

केव्हा थांबायचे नाही?

तीव्र दम, छातीत दुखणे, बेशुद्धी किंवा अचानक खूप अस्वस्थ वाटत असेल तर तातडीची वैद्यकीय मदत घ्या. डायलिसिसचे सत्र चुकले असेल, सूज वाढत असेल किंवा लघवी नेहमीपेक्षा खूप कमी झाली असेल तर त्याच दिवशी टीमला कळवा. पुढच्या नियोजित भेटीपर्यंत शांतपणे वाट पाहणे योग्य नाही.

जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

मनातले प्रश्न

“लघवी चालू आहे” म्हणजे डायलिसिस कमी करता येईल?

नाही, एवढ्यावर निर्णय होत नाही. किती सत्रे आवश्यक आहेत हे तपासण्या आणि एकूण स्थिती पाहून किडनीचे तज्ज्ञ ठरवतात.

डायलिसिस म्हणजे किडनी पूर्ण बरी झाली?

डायलिसिस रक्तातले काही टाकाऊ पदार्थ आणि जास्तीचे पाणी काढण्याचे काम करतो. तो किडनी निकामी होण्याचा कायमचा इलाज नाही.

लक्षात ठेवण्याची गोष्ट

लघवी महत्त्वाची आहे; पण सुरक्षित डायलिसिसचा निर्णय संपूर्ण चित्र पाहून होतो.

आधार आणि मूळ संदर्भ

NIDDK — hemodialysis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/hemodialysis

NIDDK — healthy eating with chronic kidney disease
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/healthy-eating-adults-chronic-kidney-disease

NIDDK — eating and nutrition on hemodialysis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/hemodialysis/eating-nutrition

American Heart Association — changes to report
https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/living-with-heart-failure-and-managing-advanced-hf/physical-changes-to-report-for-heart-failure

Government of India — Emergency Response Support System 112
https://112.gov.in/about

ही माहिती समजून घेण्यासाठी आहे. वैयक्तिक उपचारासाठी आपल्या डॉक्टरांची योजना पाळा. औषधे स्वतः बदलू नका. संदर्भ तपासले: २४ ऑक्टोबर २०२६.

Website: https://home-visiting-icu-doctor.vercel.app/#wikiSection
Article: dialysis | mr